

TEMA 2.4 • GINECOLOGÍA

Sangrado Uterino Anormal (SUA)

PERFIL EUNACOM 2.011.067

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Sangrado Uterino Anormal (SUA)

1. Nomenclatura Antigua (aún vigente en EUNACOM)

TABLA 2.4.1: TÉRMINO VS DEFINICIÓN		
TÉRMINO	DEFINICIÓN	CAUSAS PRINCIPALES
Polimenorrea	Ciclos cortos (< 21 días)	Hipertiroidismo, idiopática
Oligomenorrea	Ciclos largos (> 35 días)	SOP, anovulación, hipotiroidismo
Hipomenorrea	Regla escasa (< 2 días o < 20 mL)	ACO (atrofia endometrial)
Hipermenorrea	Regla abundante (> 7 días o > 80 mL)	Miomas, pólipos, adenomiosis, coagulopatía (Enfermedad de Von Willebrand)
Metrorragia	Sangrado fuera del ciclo	Funcional (más frecuente en edad fértil), atrofia endometrial (más frecuente en postmenopausia), hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Metrorragia ≠ Hipermenorrea: - Hipermenorrea: regla abundante → causas benignas (miomas, pólipos) - **Metrorragia: sangrado fuera del ciclo → siempre descartar cáncer de endometrio**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla nemotécnica: "ciclo" largo/corto vs. "regla" larga/corta. - Ciclo largo = oligomenorrea; Regla larga = hipermenorrea - Ciclo corto = polimenorrea; Regla corta = hipomenorrea

2. Causas — Mnemotecnía PALM-COEIN

TABLA 2.4.2: LETRA VS CAUSA	
LETRA	CAUSA
Pólipos endometriales	Sangrado intermenstrual
Adenomiosis	Hipermenorrea + útero globoso doloroso
Leiomiomas (miomas)	Hipermenorrea (no metrorragia)
Malignidad / hiperplasia	Cáncer de endometrio, hiperplasia endometrial
Coagulopatía	Enfermedad de Von Willebrand (hemostasia primaria)
Ovario disfuncional	SOP, anovulación
Endometrial	Atrofia endometrial
Iatrogénico	ACO, trauma quirúrgico, DIU
No clasificado	Idiopático

3. Manejo de la Metrorragia en Edad Fértil

Paso 0: βHCG → descartar embarazo (siempre, antes que todo)

• Paso 1: Ecografía transvaginal (ETV)

• Ver causa: miomas, pólipos, engrosamiento endometrial

• Paso 2: Biopsia de endometrio (BEM) — mecanismo Pipelle (sin anestesia, en box)

- Indicada si: endometrio engrosado en ETV, o metrorragia sin causa evidente
- Descarta **hiperplasia endometrial** y **cáncer de endometrio**

NOTA CLÍNICA

Si la ETV muestra miomas: recordar que los miomas causan **hipermenorrea**, NO metrorragia. Si hay metrorragia + miomas → igualmente hacer BEM para descartar cáncer de endometrio.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Estudio de coagulopatía (hemostasia primaria): indicado en hipermenorrea desde la **menarquia** o con clínica de hemostasia primaria (epistaxis, petequias).

4. Manejo de Metrorragia en la Postmenopausia

Paso 1: Ecografía transvaginal (el test de embarazo ya no aplica)

Decisión según grosor endometrial

TABLA 2.4.3: SITUACIÓN VS GROSOR ENDOMETRIAL			
SITUACIÓN	GROSOR ENDOMETRIAL	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Postmenopáusica sin TRH	≤ 4–5 mm	Atrofia endometrial	Tratamiento con estrógenos locales/sistémicos
Con TRH	≤ 8 mm	Atrofia endometrial	Idem
Sin TRH	> 5 mm	Sospecha hiperplasia/cáncer	BEM obligatoria
Con TRH	> 8 mm	Sospecha hiperplasia/cáncer	BEM obligatoria
Asintomática (hallazgo en ECO)	> 11 mm	Sospecha patología	BEM obligatoria

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Números clave postmenopausia (aprender de memoria — se pregunta en EUNACOM): - Sin TRH: biopsia si endometrio > 5 mm con metrorragia - Con TRH: biopsia si endometrio > 8 mm con metrorragia - Asintomática: biopsia si endometrio > 11 mm

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Sangrado Uterino Anormal (SUA), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Sangrado Uterino Anormal (SUA). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 1. Nomenclatura Antigua (aún vigente en EUNACOM)
- 2. Causas — Mnemotecnía PALM-COEIN
- 3. Manejo de la Metrorragia en Edad Fértil
- 4. Manejo de Metrorragia en la Postmenopausia
- Decisión según grosor endometrial
 - | Ciclos cortos (< 21 días) | Hipertiroidismo, idiopática |
 - | Ciclos largos (> 35 días) | SOP, anovulación, hipotiroidismo |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA))**PREGUNTA 1**

Respecto a Sangrado Uterino Anormal (SUA), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Sangrado Uterino Anormal (SUA) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Sangrado Uterino Anormal (SUA) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Sangrado Uterino Anormal (SUA) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Sangrado Uterino Anormal (SUA) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Sangrado Uterino Anormal (SUA) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Sangrado Uterino Anormal (SUA)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Sangrado Uterino Anormal (SUA). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: SANGRADO UTERINO ANORMAL (SUA)

:::note Si la ETV muestra miomas: recordar que los miomas causan hipermenorrea, NO metrorragia. Si hay metrorragia + miomas → igualmente hacer BEM para descartar cáncer de endometrio. :::
:::tip Estudio de coagulopatía (hemostasia primaria): indicado en hipermenorrea desde la menarquía o con clínica de hemostasia primaria (epistaxis, petequias). :::